

Üst GİS Kanaması (Hematemez–Melena)

Treitz ligamenti proksimalinden kaynaklanan kanamada resüsitasyon, asit baskılama, varis kanamasında vazoaktif tedavi, endoskopi zamanlaması ve balon tamponadının dozlu ve basamaklı yönetimi.

Hematemez

Melena

Varis / Non-varis

Acil Endoskopi

01 Tanım ve İlk Değerlendirme

Üst GİS kanaması, Treitz ligamenti proksimalindeki kaynaktan gelişen kanamadır; hematemez (taze/parlak kırmızı veya kahve telvesi kusma) ve/veya melena ile ortaya çıkar. İlk hedef, kanamanın kaynağını aramadan önce hemodinamik stabilizasyon (A-B-C) ve varis / non-varis ayırımıdır. Masif kanamada hematokezya da üst kaynaklı olabilir.

İlk 15 dakika: İki geniş çaplı damar yolu (mümkün olan en büyük kanül), tam kan sayımı, koagülasyon (PT/INR/aPTT/fibrinojen), grup-cross, KCFT, üre/kreatinin, kan gazı-laktat. Kan basıncı düşmeden önce taşikardi ve kapiller dolum uzaması tek erken bulgu olabilir; çocukta hipotansiyon geç ve dekompanse şok işaretidir.

Odaklı Öykü

- Kusmanın rengi/miktarı: taze kırmızı vs kahve telvesi; öksürük/burun kanaması ile karışım (yalancı hematemez)?
- Melena süresi ve gaita rengi; sayı ve volüm.
- Bilinen karaciğer hastalığı, portal hipertansiyon, umbilikal ven kateterizasyonu öyküsü (portal ven trombozu).
- NSAİİ, kortikosteroid, antikoagülan kullanımı; kostik/yabancı cisim yutma.
- Öncesinde şiddetli, tekrarlayan kusma (Mallory-Weiss); epistaksis, diş çekimi.
- Yenidoğanda: anne meme çatlağı / yutulmuş maternal kan (Apt-Downey testi), K vitamini profilaksisi öyküsü.

Odaklı Muayene

- Vital bulgular + ortostatik değişiklik; nabız basıncı, kapiller geri dolum, bilinç düzeyi.
- Kronik karaciğer hastalığı: hepatosplenomegali, asit, karın duvarı kollateralleri (kaput meduza), sarılık, palmar eritem.
- Cilt: peteşi/purpura (koagülopati, HÜS-benzeri), hemanjiyom (GİS hemanjiyomatozis).
- Nazofarinks/orofarinks muayenesi (yalancı kanama kaynağı dışlama).
- Rektal muayene: melena/hematokezya doğrulaması, gaitada gizli kan.
- Nazogastrik aspirat: taze kan/telve üst kaynağı destekler (negatif aspirat kanamayı dışlamaz).

Etiyoloji yaş grubuna göre belirgin değişir; tedavi kolu (varis vs non-varis) ampirik başlanır ve endoskopiyle netleşir.

Yenidoğan

- Yutulmuş maternal kan (Apt-Downey ile ayır)
- Hemorajik hastalık (K vitamini eksikliği)
- Stres gastriti / ülser
- İnek sütü protein enteropatisi

Süt Çocuğu

- Reflü özofajiti, gastrit
- Stres ülseri (kritik hastalık)
- Mallory-Weiss (şiddetli kusma)
- Vasküler malformasyon

Okul Öncesi

- Özofagus/gastrik varis (portal HT)
- Peptik ülser, H. pylori gastriti
- Kostik/yabancı cisim hasarı
- İlaça bağlı (NSAİİ) mukozal hasar

Adölesan

- Peptik ülser / H. pylori
- Özofagus varisi (siroz, PVT)
- Mallory-Weiss yırtığı
- Dieulafoy lezyonu, malignite (nadir)

Non-Varis Mekanizma

- Asit-peptik mukozal erozyon/ülser
- Mukoza-müsküler yırtık (Mallory-Weiss)
- Anjiodisplazi / Dieulafoy arteri
- PPI ile asit baskılama yanıtı

Varis Mekanizma

- Portal hipertansiyon → kollateral basınç artışı
- Özofageal/gastrik varis rüptürü
- Vazoaktif ilaç (oktreotid) + antibiyotik gerekir
- Yüksek volüm, hızlı dekompanseasyon riski

Stabilizasyon ile eş zamanlı olarak varis / non-varis kolu ampirik başlatılır; endoskopi zamanlaması hemodinamik yanıtı göre belirlenir.

BAŞLANGIÇ**Aktif hematemez / melen**

ABC değerlendir, iki geniş damar yolu, monitörizasyon, laboratuvar + grup-cross gönder.

ADIM 1**Resüsitasyon**

Kristaloid 20 mL/kg bolus; yanıtızsızsa tekrarla. Eritrosit süspansiyonu hedef Hb 7 g/dL (restriktif); aktif masif kanamada erken transfüzyon.

KARAR 1**Portal hipertansiyon / karaciğer hastalığı var mı?**

Hepatosplenomegali, asit, kollateral, bilinen siroz/PVT veya tipik varis öyküsü?

EVET → Varis kolu

HAYIR → Non-varis kolu

VARİS PROTOKOLÜ**Vazoaktif + antibiyotik + PPI**

Oktreotid bolus + infüzyon başla, seftriakson profilaksisi ver, PPI ekle; acil endoskopiye hazırla (bant ligasyonu / skleroterapi).

ASİT BASKILAMA**Yüksek doz IV PPI**

PPI bolus + sürekli infüzyon başla; NSAİİ/steroid kes; endoskopiye stabilizasyon sonrası planla.

KARAR 2**Resüsitasyona rağmen hemodinamik stabilize oluyor mu?**

2 kan hacmi replasmanı sonrası devam eden hipotansiyon / masif kanama?

HAYIR → Stabil değil

EVET → Stabil

ACİL ENDOSKOPI**Stabilizasyon sonrası <12 saat**

Devam eden varis kanamasında endoskopik hemostaz başarısız/ulaşılamıyorsa Sengstaken-Blakemore/Minnesota balon

PLANLI ENDOSKOPI**İlk 24 saat içinde**

Medikal tedaviye devam, seri Hb izlemi, elektif endoskopi; tanısal + gerekirse terapötik girişim.

tamponadı ile köprüle; TIPS/girişimsel radyoloji için değerlendir.

Tetkikler stabilizasyonu geciktirmeden, kanama kolu belirlemeye ve endoskopiye hazırlığa yönelik basamaklandırılır.

Üst GİS kanamasında basamaklı tanısal yaklaşım		
BASAMAK	TETKİK / EŞİK	AMAÇ
Basamak 1 — Kaynağı doğrula	NG aspirat, gaita gizli kan, Apt-Downey (yenidoğan)	Yalancı ve yutulan materyal nedeniyle NG negatif kanama
Basamak 2 — Kan / koagülasyon	Hb izlemi hedef ≥ 7 g/dL; INR, fibrinojen, trombosit	Seri he- saatleri hemod- nedeni- yanıtıcı koagüle düzelt.
Basamak 3 — Organ/etioloji paneli	KCFT, albümin, üre/kreatinin, kan gazı-laktat	Yüksek üre/kre- üst kay- destekl- albümin- ipuçları perfüzy-
Basamak 4 — Görüntüleme	Doppler USG (portal ven, dalak boyutu, asit)	Portal H- değerle- varis ko- destekl- Radyas- hızlı.
Basamak 5 — Üst endoskopi	Stabilde <24 saat, instabilde stabilizasyon sonrası <12 saat	Altın st- terapi (ligasyo- sklerote- adrena- Forrest

BASAMAK	TETKİK / EŞİK	AMAÇ
		ile yeni riskini c
Basamak 6 — İleri değerlendirme	Kapsül / anjiyografi / Meckel sintigrafisi (seçilmiş)	Endosk ama de kanama kaynak masif k CT- anjiyog radyolo

05 Kırmızı Bayraklar

Aşağıdaki bulgular masif/varis kanaması ve hızlı dekompanse riskine işaret eder; acil endoskopi ve yoğun bakım eşiğini düşürür.

- Taşikardi + kapiller dolum uzaması, bilinç değişikliği (kompanse şok)

- Hipotansiyon (geç bulgu — dekompanse şok)

- Devam eden taze hematemez veya hematokezya (masif kanama)

- Bilinen siroz / portal hipertansiyon / özofagus varisi

- 2 kan hacmi replasmanına rağmen devam eden instabilite

- INR uzaması / trombositopeni / düşük fibrinojen (koagülopati)

- Yükselen laktat, metabolik asidoz, oligüri

- Hb'de hızlı düşüş veya transfüzyon gereksiniminin sürmesi

Non-varis kolunda yüksek doz PPI, varis kolunda vazoaktif ilaç + antibiyotik esastır; koagülopati düzeltilir. Dozlar mg/kg (veya mcg/kg) ve maksimum değerle verilmiştir.

İlke: Vazoaktif ve asit-baskılayıcı tedavi endoskopiye beklemeden ampirik başlatılır. Restriktif transfüzyon (hedef Hb ~7 g/dL) varis kanamasında yeniden kanamayı azaltır; aşırı volüm portal basıncı artırır.

Üst GİS kanamasında ilaç ve girişim dozları

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG VEYA MCG/KG + MAKSİMUM)
Kristaloid bolus	20 mL/kg IV, yanıtı göre tekrar
Eritrosit süspansiyonu	10–15 mL/kg IV; hedef Hb ~7 g/dL
Pantoprazol / Esomeprazol (IV PPI)	Yükleme 1 mg/kg IV (maks 80 mg), ardından 0,1–0,2 mg/kg IV
Oktreotid (varis)	Bolus 1–2 mcg/kg IV (maks 50 mcg), ardından 1–2 mcg/kg IV
Seftriakson (varis profilaksisi)	50 mg/kg/gün IV (maks 2 g/gün)
K vitamini	Yenidoğan 1 mg IV; çocuk 1–10 mg IV (yavaş)
Taze donmuş plazma	10–15 mL/kg IV

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ (MG/KG VEYA MCG/KG + MAKSİMUM)
Trombosit süspansiyonu	10–15 mL/kg (veya 1 Ü/10 kg)
Sengstaken-Blakemore / Minnesota tüpü	Özofagus balonu 25–45 mmHg; <24 saat

Dikkat: Traneksamik asit üst GİS kanamasında rutin önerilmez (yarar gösterilmemiş, tromboembolik risk). Vazopressin çocuklarda oktreotid yerine ilk tercih değildir. Balon tamponadı yalnızca deneyimli elde, hava yolu güvenceye alınarak ve kısa süreli uygulanır.

Amaç yeniden kanamayı erken saptamak, altta yatan nedeni tedavi etmek ve varis kaynağında sekonder profilaksiyi kurmaktır.

Akut İzlem

- Sürekli monitörizasyon; instabil/masif kanamada yoğun bakım.
- İlk 24–48 saat seri Hb (6–8 saatte bir) ve hemodinamik trend.
- NG dekompresyon/gözlem (seçilmiş); yeniden taze kan gelişi → endoskopiye tekrarla.
- Sıvı dengesi, idrar çıkışı, laktat klerensi takibi.
- PPI infüzyonunu klinik stabilite ile oral yüksek doza geçir.

Kaynağa Yönelik / Sekonder Profilaksi

- Peptik ülser + H. pylori pozitif: eradikasyon tedavisi ve 4–8 hafta PPI.
- Varis: taburculuk öncesi bant ligasyonu programı + non-selektif beta bloker (propranolol) titrasyonu değerlendir.
- Portal HT etiyolojisini araştır (siroz, PVT); hepatoloji/transplant konseyi.
- NSAİİ/gastrotoksik ilaçları kes; gerekiyorsa mide koruması.
- Refrakter/tekrarlayan varis kanamasında TIPS veya cerrahi şant için değerlendir.
- Aile eğitimi: alarm bulguları, gaita rengi izlemi, ilaç uyumu.

Restriktif transfüzyon

Erken vazoaktif tedavi

Endoskopik hemostaz

H. pylori eradikasyonu

Beta bloker profilaksi

Kaynaklar

1. Shneider BL, de Ville de Goyet J, Leung DH, et al. Primary Prophylaxis of Variceal Bleeding in Children and the Role of MesoRex Bypass: Summary of the Baveno VI Pediatric Satellite Symposium. Hepatology. 2016.
2. Thomson M, Tringali A, Dumonceau JM, et al. Paediatric Gastrointestinal Endoscopy: ESPGHAN and ESGE Guidelines. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2017.
3. NASPGHAN. Management of Acute Gastrointestinal Bleeding in Children — Clinical Practice Guidance. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2021.
4. de Franchis R, et al. Baveno VII — Renewing Consensus in Portal Hypertension. J Hepatol. 2022.

Uyarı: Bu belge pediyatrik gastroenteroloji uzmanları için hazırlanmış bir klinik karar destek aracıdır; bireysel hasta değerlendirmesi, güncel kılavuzlar ve kurumsal protokollerin yerini tutmaz. Dozlar doğrulanmalı ve hasta bazında ayarlanmalıdır.